

Fecha Última Actualización: 11-05-2022 12:19:16

Página 1 de 2

Información Paciente

Nombre : Verónica De Las Mercedes Riquelme He **Rut** : 6.912.133-0 **N° Archivo** : 0635207
Edad : 69a 4m 6d **Fecha Nacto**: 29/12/1952 **Sexo** : Femenino
Dirección : Pje Dalcahue 8960 0 **Comuna** : La Granja **Teléfono** : 949006019

N° Epicrisis
306032

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Cirugía Sector B - Mediana Compleji **Fecha Ingreso** : 29/04/2022 14:25 **Días Estadía** : 6
Unidad de Egreso : Cirugía Sector A - Alta Complejidad **Fecha Egreso** : 05/05/2022 16:05

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Estenosis mitral severa

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

ANTECEDENTES

- Mórbitos: Insuficiencia cardíaca crónica CF III. Estenosis mitral severa. Insuficiencia tricuspídea severa. Hipertensión pulmonar PAPS 74 mmHg. Flutter auricular en TACO. Hipertensión arterial. Diabetes mellitus 2.
- Medicamentos: Losartán, Atenolol, Furosemida, Epsironolactona, Atorvastatina, Acenocumarol.
- Quirúrgicos: Amigdalectomía, apendicectomía, colecistectomía.
- Hábitos: Tabaquismo suspendido hace 2 años.
- Alergia: Al níquel

HISTORIA ACTUAL

Ingresa derivada para Cirugía por una Estenosis Mitral, estando en control con Dra Saavedra en HPH, con historia de 2 años de disnea de medianos esfuerzos.

Ecocardiograma demostró válvula mitral con estenosis severa e insuficiencia leve, válvula aórtica con esclerosis sin significación hemodinámica. Disfunción del VI sistólica leve FE 49%, AI severamente dilatada, IT tricuspídea severa, con disfunción del ventrículo derecho, dilatado, PAPS 74.

Coronariografía sin lesiones. TAC muestra importante Cardiomegalia y calcificación de la válvula mitral

Ingresa para cardiocirugía electiva, realizándose pabellón el 01/05/22. Reemplazo valvular mitral con prótesis mecánica Saint Jude 29, plastía tricuspídea con anillo Edwards Physio mc328 y cierre de orejuela izquierda. Con posterior salida a UPC para continuar manejo.

Adecuada evolución clínica, extubación en tiempos adecuados. se inicia ajuste de medicamentos antihipertensivos, analgésicos, se retiran drenajes por débitos escasos y cables, radiografía de control sin neumotórax no derrame, se inicia traslape a TACO logrando INR 2.67, Ultimos exámenes 08/05/2022 HTO 30 GB 4800 PLQ 137000 K 4 PCR 65 CREA 0.5 estenon firme, herida sin signos de infección local. En condiciones de ALTA

Diagnóstico de Egreso

Estenosis Mitral Severa -
Reemplazo Valvular Mitral Mecánico -
Hta -

Fecha Epicrisis : 11/05/2022 12:19

Página 1 de 2

Fa En Taco -

Condición de Egreso Otro

Egreso con Catéter Doble J: NO

Ben estado general, afebril, hidratada

Plan Post Alta

1. Reposo Relativo USO PERMANENTE DE FAJA EN TÓRAX
2. Régimen hiposódico
3. Omeprazol 20mg cada día por 30 días
4. Atorvastatina 40mg cada noche por 30 días
5. Losartan 25mg cada día por 30 días
6. Carvedilol 3.125mg cada día por 30 días
7. Amiodarona 200mg cada día por 30 días
8. Paracetamol 1gr cada 8 horas por 10 días
9. Bromuro de ipratropio + fenoterol 2puff cada 8 horas
10. Acenocumarol segun esquema asi: 11/05 (1/2comp) - 12/05 (1/4comp) - 13/05 (1/2 comp) - 14/05 (1/2 comp) - 15/05 (1/4comp) - 16/05 (1/2 comp) - 17/05 (1/4 comp)
11. Control Poli de TACO en CDT (Agendar hora en 1 semana)
12. Control CDT pasillo 8 Dr. Demian Fullerton en 2 semanas (Agendar hora con señorita Claudia Mena)

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Liliana Moreno Pantoja
Becado/Residente



Tomás Lahera Frohmann
Médico Tratante (Staff)